
MONOGRAFÍA DEL PRODUCTO

DEXTOS

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

DEXTOS, 27 mg/15 ml, jarabe

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

27 mg de bromhidrato de dextrometorfano por 15 ml de jarabe.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Jarabe.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

DEXTOS es utilizado en el tratamiento sintomático de la tos improductiva causada por irritación de las vías respiratorias altas o bajas.

4.2. Posología y forma de administración

En adultos y adolescentes (mayores de 12 años): 15 ml cada 6 ó 8 horas. Dosis máxima diaria recomendada de 60 ml.

Niños de 6 a 12 años: 7,5 ml cada 6 ó 8 horas. Dosis máxima diaria recomendada de 30 ml

Niños de 2 a 5 años: la posología será según indicación médica.

Niños *menores de 2 años*: no se recomendada su utilización.

No sobrepasar las dosis recomendadas o utilizar por periodos largos.

El jarabe puede tomarse diluido en agua o sin diluir.

4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los excipientes. Tos productiva. Tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO).

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

DEXTOS debe administrarse con precaución en pacientes asmáticos o atópicos, puesto que puede desarrollar liberación de histamina. Y también en pacientes sedados o debilitados.

En pacientes con enfermedad hepática ya que puede alterarse el metabolismo del dextrometorfano.

Si la tos persiste más de una semana, si reaparece o si va acompañada de fiebre alta, erupción en la piel o cefaleas intensas, un médico debe ser consultado.

DEXTOS contiene 121,64 g de sacarosa por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 9,123 g de sacarosa. No debe ser utilizado en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, síndrome de malabsorción de glucosa-galactosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa.

DEXTOS contiene 2,75 g de etanol al 96% por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 0,20 g de etanol al 96%. Puede ser perjudicial para los pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, enfermedad o traumatismo cerebral, y también para las mujeres embarazadas y niños. Puede alterar o aumentar el efecto de otros medicamentos.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

La utilización simultánea de DEXTOS e inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) puede iniciar crisis adrenérgicas, coma, vértigo, excitabilidad, hipertensión, hiperpirexia, hemorragia intracerebral, letargia, náusea, comportamientos psicóticos, espasmos musculares, temblores y, eventualmente, muerte, por lo que la administración simultánea está contraindicada. No administrar dextrometorfano hasta pasados 14 días del tratamiento con los inhibidores de la MAO.

Los medicamentos con acción depresora sobre el sistema nervioso central y el dextrometorfano, cuando utilizados concomitantemente, pueden potenciar sus efectos. La administración de DEXTOS concomitantemente con quinidina, fluoxetina, paroxetina y venlafaxina, puede aumentar el riesgo de reacciones adversas.

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

Aunque no existan datos evidentes relacionados con problemas fetales debido al dextrometorfano durante el embarazo o interferencia en el sistema reproductivo, DEXTOS no está recomendado durante el embarazo y la lactancia.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas

DEXTOS no interfiere en la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

4.8. Reacciones adversas

Las reacciones adversas debidas a la utilización de DEXTOS son raras, pudiendo manifestarse, a veces, trastornos gastrointestinales, tales como náuseas y vómito, dolores de estómago, mareos y vértigo.

4.9. Sobredosis

Las manifestaciones observadas tras la ingesta masiva de dextrometorfano fueron náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, nistagmus, ataxia, retención urinaria, depresión respiratoria, estupor, psicosis tóxica (hiperactividad, alucinaciones visuales y auditivas) y coma. En caso de sobredosis se utilizarán medidas de tratamiento sintomático y de soporte y administración de naloxona intravenosa y administración oral de carbón activo.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Código ATC: R05D A09.

El dextrometorfano es un antitusivo de acción central. Es un isómero del levorfanol, un análogo de la codeína. Al contrario de otros isómeros, el dextrometorfano es desprovisto de propiedades analgésicas, no causa dependencia y no actúa a través de los receptores opiáceos. Sus propiedades antitusivas resultan de su acción directa en el centro medular de la tos, aumentando su umbral de sensibilidad. Su potencia antitusígena es similar a la de la codeína, manteniéndose sus efectos durante 6 horas. Al revés de la codeína, su acción sedativa es prácticamente despreciable, observándose solamente con dosis extremadamente elevadas.

A dosis terapéuticas no inhibe la actividad ciliar de las vías respiratorias, lo que presenta una ventaja cuando comparado con otros fármacos antitusivos.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

El dextrometorfano es rápidamente absorbido en el tracto gastrointestinal. El T_{max} es de 2 a 2,5 horas y la C_{max} tras una dosis oral de 60 mg es de 5,2 ng/ml. El efecto antitusígeno ocurre 15 a 30 minutos tras la administración oral y la duración de acción es de aproximadamente 5-6 horas.

El dextrometorfano se distribuye en el SNC, alcanzando concentraciones detectables en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Estudios animales han demostrado que la relación concentración LCR/plasma varió entre 32,8 y 80%.

El fármaco sufre rápida y extensa metabolización hepática, originando un metabolito activo (dextrorfanol) y dos inactivos (3-metoximorfinano y morfinano-3-1). El dextrometorfano es metabolizado por la isoenzima CYP2D6, sufriendo desmetilación oxidativa.

El dextrometorfano y sus metabolitos desmetilados son excretados por vía urinaria. La semivida de eliminación del dextrometorfano es de 1,4 a 3,9 horas y del dextrorfanol es de 3,4 a 5,6 horas.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

El dextrometorfano es un medicamento de uso corriente, y se halla descrito en prácticamente todas las farmacopeas.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

Sacarosa (9,123 g/15 ml), ácido cítrico anhidro, metilparabeno, esencia de naranja líquida, etanol al 96 por ciento y agua purificada.

6.2. Incompatibilidades

En ausencia de estudios de incompatibilidades este medicamento no debe mezclarse con otros.

6.3. Periodo de validez

5 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

No requiere precauciones especiales de conservación.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

Envase conteniendo un frasco de vidrio, tipo III, de color ámbar, y un prospecto. El frasco contiene 200 ml de jarabe. Incluye un vaso dosificador.

6.6. Precauciones especiales de eliminación

No procede.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO

BIAL – Portela & C^a, S.A.

À Avenida da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

F012912042018

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Fecha de la Primera Autorización: 20/04/2018

Fecha de Renovación de la Autorización:

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

Bibliografía:

1. Dextromethorphan. In American Hospital Formulary Service 2009, p. 2812-2816
2. Dextromethorphan. In USP Drug Information for the Health Care Professional 27th Ed. (2007), p. 1057-1059.
3. Hildebrand M, Seifert W, Reichenberger A. Determination of dextromethorphan metabolizer phenotype in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 1989;36:315-318.
4. Silvasti M, Karttunen P, Tukiainen H et al. Pharmacokinetics of dextromethorphan and dextrorphan: a single dose comparison of three preparations in human volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1987; 9:493-497.
5. Vernacchio L, Kelly JP, Kaufman DW, Mitchell AA. Cough and cold medication use by US children, 1999–2006: results from the slone survey. Pediatrics. 2008;122:e323–e329.
6. Paul IM, Beiler J, McMonagle A, Shaffer ML, Duda L, Berlin CM., Jr. Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007; 161(12):1140–6.
7. Paul IM, Yoder KE, Crowell KR, Shaffer ML, McMillan HS, Carlson LC, Dilworth DA, Berlin CM Jr. Effect of dextromethorphan, diphenhydramine, and placebo on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents. Pediatrics. 2004; 114(1):e85-e90.